

Reconstruction de l'uretère

WARWIKI

Information pour le patient · Chirurgie pour réparer un uretère obstrué ou rétréci

La reconstruction de l'uretère est une chirurgie visant à réparer un uretère obstrué ou rétréci — le tube qui achemine l'urine du rein à la vessie — afin de rétablir un drainage normal et de protéger le rein. La technique dépend de l'emplacement et de l'étendue du rétrécissement : on peut réunir les extrémités saines, utiliser une greffe de tissu ou interposer un segment d'intestin.

À propos de cette intervention

Un **rétrécissement** (cicatrice) de l'uretère bloque l'urine en amont et peut endommager le rein. La réparation est adaptée au rétrécissement :

- **Rétrécissement court** — le segment atteint est retiré et les extrémités saines sont suturées, ou l'uretère est reconnecté à la vessie (la vessie peut être remontée pour l'atteindre).
- **Rétrécissement plus long** — l'uretère est élargi avec une **greffe**, souvent un petit morceau de muqueuse prélevé à l'intérieur de votre joue.
- **Domage étendu ou grave** — un segment de votre propre **intestin** est utilisé pour remplacer la partie de l'uretère manquante.

Une **sonde JJ** (endoprothèse souple) est placée à l'intérieur pour maintenir la réparation ouverte pendant la cicatrisation. L'intervention se fait généralement par **chirurgie robotique ou laparoscopique** (mini-invasive), parfois à ciel ouvert. Les taux de succès sont élevés.

Est-ce sans danger ?

Ces réparations sont bien établies et efficaces, adaptées à votre anatomie. Comme toute chirurgie majeure, il existe certains risques : saignement, infection ou fuite urinaire temporaire (généralement gérée par la sonde et un drain). La récurrence du rétrécissement est peu fréquente. Si un segment d'intestin est utilisé, l'intestin a besoin de quelques jours pour récupérer et vous pourriez noter un peu de mucus dans les urines.

COMPRENDRE LES TERMES

Uretère

Tube qui achemine l'urine du rein à la vessie.

Rétrécissement

Zone cicatricielle rétrécie qui ralentit ou bloque l'écoulement de l'urine.

Sonde JJ (endoprothèse)

Tube souple interne en forme de « double J » qui maintient la réparation ouverte pendant la guérison.

Greffe

Petit morceau de tissu prélevé sur vous-même (souvent à l'intérieur de la joue) pour élargir l'uretère.

Segment d'intestin

Courte portion de votre propre intestin utilisée pour combler un long manque.

Réimplantation

Reconnexion de l'uretère à la vessie.

Hydronéphrose

Dilatation du rein due à l'accumulation d'urine en amont de l'obstruction.

Robotique / laparoscopique

Chirurgie mini-invasive réalisée par quelques petites incisions.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? L'intervention se fait sous anesthésie générale : vous ne sentez rien. Ensuite, les incisions sont sensibles ; la sonde interne peut provoquer une urgenturie ou une légère gêne au flanc. Si un segment d'intestin est utilisé, l'intestin met quelques jours à « se réveiller ». Hospitalisation de 1 à 3 nuits.

Comment vous préparer (Avant la chirurgie)

- Intervention sous **anesthésie générale** — suivez toutes les consignes (jeûne, médicaments à suspendre, y compris les anticoagulants).
- Un **analyse d'urine** recherche une infection — celle-ci doit être traitée avant l'opération.
- **Ne fumez pas** — le tabac ralentit la cicatrisation. Si un segment d'intestin est envisagé, une préparation intestinale peut être nécessaire ; si une greffe de joue est prévue, prenez soin de votre bouche.
- Prévoyez de porter la **sonde pendant environ 4 à 6 semaines** et organisez votre retour à domicile.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Prenez un **anticoagulant** ou avez une infection en cours
- Avez subi une chirurgie abdominale ou pelvienne antérieure, ou une radiothérapie

Déroulement de la chirurgie

- 1 Vous êtes endormi(e) sous anesthésie et des antibiotiques vous sont administrés.
- 2 Le chirurgien pratique de petites incisions ou une incision ouverte et expose le segment rétréci.
- 3 L'uretère est réparé — extrémités réunies, élargi par une greffe ou remplacé par un segment d'intestin — sur une sonde JJ.
- 4 Un petit drain peut être laissé en place ; les incisions sont fermées.

Après la chirurgie

- Vous rentrez généralement à domicile après **1 à 3 jours**.
- La **sonde reste en place environ 4 à 6 semaines**, puis elle est retirée lors d'une cystoscopie rapide en consultation.
- Les symptômes liés à la sonde — urgenturie, légère gêne au flanc ou urines rosées — sont **normaux**.
- Si un segment d'intestin a été utilisé, mangez légèrement pendant la récupération intestinale. **Évitez les efforts importants** pendant quelques semaines.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Une douleur sévère ou croissante au flanc ou à l'abdomen
- Un saignement abondant ou une impossibilité d'uriner
- Des vomissements persistants ou une absence de gaz ou de selles (si l'intestin a été utilisé)
- Une rougeur, une douleur ou un écoulement croissant au niveau d'une incision

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La reconstruction de l'uretère rouvre un uretère obstrué pour protéger le rein. La réparation est adaptée à votre cas : réunion des extrémités, greffe de joue ou segment d'intestin, sur une sonde interne.
2. Avant l'opération : jeûne et consignes médicamenteuses, traitement de toute infection, pas de tabac, sonde 4 à 6 semaines, retour organisé.
3. La sonde peut causer de l'urgenturie jusqu'à son retrait en consultation.